# 2026年卫生学简答题答案

**1. 简述幼儿园户外体育活动的卫生要求与指导**

（1）保证充足的户外体育活动时间。

（2）玩具、材料符合卫生安全要求。

（3）场地整洁、适宜。

（4）注意安全、动静交替。

（5）活动过程的组织有序。

（6）活动后收拾物品放回原处。

**2. 简述教育教学活动的卫生要求与指导**

（1）保持教室环境安全卫生，室内地面清洁不起尘、光线充足、空气新鲜，定期交换幼儿座位，保护幼儿视力。

（2）培养幼儿正确坐、立、行姿势和握笔姿势，保护幼儿视力和嗓子。

（3）要根据各年龄班幼儿的特点安排活动时间和内容。有统一要求又注意根据幼儿个体差异，不强求一律。

（4）以幼儿为主体，面向全体幼儿，让幼儿充分运用感官，动脑，动口，动手，启发幼儿学习的积极性、主动性和创造性。逐渐养成动脑、动手和手脑并用的习惯。

（5）教态亲切自然，情感真挚。语言清晰，简练，准确，规范，生

微光也是光

动形象。

**3. 简述七步洗手法步骤**

第 1 步，洗手掌。掌心对掌心，手指并拢，相互搓揉。

第 2 步，洗手背。手心对手背，手指交叉。沿指缝相互揉搓，双手交换进行。

第 3 步，洗指缝。掌心对掌心，手指交叉，相互揉搓。

第 4 步，洗指背。一手弯曲呈空拳，放另一手的手心，旋转搓揉。双手交换进行。

第 5 步，洗拇指。一手握住另一只手的大拇

指，旋转搓揉。双手交换进行。

第 6 步，洗指尖。一手五指指尖并拢，放在另一只手的手心，旋转搓揉。双手交换进行。

第 7 步，洗手腕。一手握住另一只手的腕部旋转搓揉。双手交换进行。

**4. 幼儿骨骼的特点**

（1）骨骼在生长

（2）腕骨没钙化好

（3）骨盆还没长结实

微光也是光

（4）骨头好比鲜嫩的柳枝

（5）脊柱易变形

**幼儿肌肉的发育特点**

（1）幼儿的肌肉容易疲劳，但消失快

（2）幼儿的肌肉容易受损伤

（3）大肌肉发育早，小肌肉发育晚

（4）肌肉具有粘滞性

**5. 幼儿生长发育基本规律**

（1）生长发育既有连续性又有阶段性

（2）生长发育的速度是波浪式的

（3）生长发育具有不均衡性

（4）生长发育具有相互关联性

（5）生长发育的个体差异性

微光也是光

**6.简述幼儿烫伤的处理措施**

（1）轻度的烧烫伤首先要用流水冲洗伤处，进行冷却处理（20-30分钟），然后可在皮肤处涂以甘油、凡士林、万花油等

（2）有水泡不能涂油或挑破水泡，盖上干净纱布或毛巾，马上送医

（3）若烫伤严重，面积较大，应尽快把烫湿的衣服脱掉，不要涂药，用干净被单将伤者包裹起来，尽量少碰，立即送医院治疗。

（4）烫伤处理中绝不能用牙膏、松香之类的东西，因为其可增加医生的清理难度，让孩子更痛苦，还会因为伤处渗出液积累，而出现滋生细菌、感染等情形。

**简述幼儿溺水的急救措施。**

（1）若儿童落入深水，抢救者向其接近时一定要小心，最好从背后入，将落水者头部托起或从上面拉起胸部，使其面部露出水面，然后托其上岸。

（2）救上岸后进行如下急救：

①迅速清除溺水者口鼻内的淤泥杂草。松解内衣、裤带。

②控水。若溺水者有呼吸、心跳，可进行控水。救护者取半跪姿势，将溺水者趴在救护者的膝盖上，使其头部下垂，按压其腹、背部，使溺水者口、咽及气管内的水控出。若已无呼吸心跳，先进行心肺复苏。

③迅速复苏。检查溺水者呼吸、心跳的情况。有心跳、无呼吸者，可作口对口人工呼吸。如果心跳、呼吸都停止了，应就地进行胸外心脏

挤压和口对口人工呼吸，以保证溺水者脑的血流灌注，不至于因缺氧造成不可逆的损害。复苏开始得越早，成功率越高。

**7. 简述幼儿耳的卫生保健**

（1）冬天注意头部保暖，预防耳朵生冻疮

（2）禁止用锐利的工具为幼儿挖耳

（3）预防中耳炎

（4）减少噪声，发展幼儿听力

（5）对婴幼儿的听力进行监测

**升级版：简述幼儿异物入耳的处理**

外耳道异物，常可引起耳鸣、耳痛、引发中耳炎。

1. 植物性异物进入外耳道，如遇水膨胀会继发感染引起外耳道炎。

2. 动物性异物在外耳道内爬行、移动可引起剧痛。体积大的异物还会引起反射性咳嗽或影响听力。

3. 活体昆虫进入外耳道，可用灯光诱其爬出，如不成功可滴入油类，将其淹死，再行取出。

4. 对于体积较小的异物，可让幼儿将头歪向有异物一侧，单脚跳，以促使异物从耳中掉出来。

5. 对于不易取出的异物，应去医院处理，以免损伤外耳道及鼓膜。

微光也是光

**8. 幼儿在幼儿园发生意外出血常用止血的方法有哪些**

（1）加压包扎止血法；

（2）指压止血法；

（3）止血带止血法；

（4）一般止血法。

**9. 简述幼儿园隔离制度主要包括哪些方面？**

① 重视隔离室的设置；

② 对患儿应及时进行妥善的隔离；

③ 对可疑患儿和传染病接触者进行隔离和观察；

④ 学前儿童离开园所返回时要进行观察与检疫。

**简述幼儿园的消毒制度包括哪些方面？**

①消毒制度是幼儿在园期间健康生活的重要保证。按幼儿园消毒制度规定，幼儿用的餐具、水杯、餐桌应每餐后进行消毒，毛巾每天消毒1次；

②门把手、房间地面、盥洗间地面等应每天在幼儿入园前进行消毒；

③坐便器应随用随消毒，蹲便器每天进行消毒；

④每天幼儿离园后对教室空气进行消毒；

⑤各种用具、玩具、图书应每周消毒1次

微光也是光

**10. 简述幼儿口吃的矫治措施**

（1）解除说话时的紧张情绪，并注意消除不良刺激。

（2）加强说话训练，多让幼儿练习朗诵、唱歌。

（3）和谐的家庭氛围。

（4）正确的教育方法。

（5）有规律的生活，充足的睡眠（有助于恢复正常的语言节律）。

微光也是光

# 卫生学案例分析答案

押题 1 参考答案：

（1）对该儿童口吃原因的分析

儿童口吃的原因有生理性的，但更多为心理性的。从材料提供的信息可推断出该儿童患口吃的原因为心理性的。具体的原因可能有以下几个：

①儿童说话时过于急躁、激动和紧张，低龄儿童在急于表达自己的思想时，容易出现言语节奏的障碍。

②家长对儿童语言的表达做过多矫正，如经常提醒、纠正孩子的说话习惯，并采用吓唬、惩罚等方法来训练语言，造成孩子的精神过度紧张而引起口吃。

③儿童由于口吃受到讥笑、指责，从而变得沉默、自卑，进一步加重了口吃症状。

（2）矫治措施

①为儿童创设宽松的言语氛围，解除儿童的紧张情绪。

②成人与儿童讲话要心平气和、不慌不忙，使儿童受到感化，养成从容不迫的讲话习惯。

③对儿童进行口型示范和发音矫正训练，可以多练习朗诵和唱歌。

④对儿童说话的每一点进步，父母都应及时强化、鼓励。

押题 2 参考答案：

(1) 小雨对打雷有心理恐惧，这是一个儿童心理恐惧的行为，

可能的原因：

学前儿童恐惧症的产生原因多与个性特征和早期经历有关。性格胆小、敏感的儿童，容易受他人暗示产生惧怕：不正确的教育方法，如威胁恐吓、过度溺爱和保护、成人的“示范”等会导致学前儿童的恐惧。小雨的恐惧与家长不正确的教育方式有关，材料中，千寻妈妈是直接让孩子逃避自己的一个恐惧的行为，千寻爸爸就是用强硬的态度让孩子接受事实对于千寻爸妈的做法都是不太合适。对于儿童心理恐惧千寻的爸妈还没有及时做好一个榜样，也没有针对性地说明这个雷电产生的原因，也没有询问孩子的一个真实的想法，在没有交流沟通的情况下，就做了两种不太适合孩子身心健康发展。

(2)

① 系统脱敏、模拟示范、心理暗示等方法可消除或者减轻儿童的恐惧反应

② 首先，在学前儿童成长过程中，不要采用恐吓手段教育孩子，避免让学前儿童看恐怖、血腥的影视和图片

③ 其次，鼓励学前儿童多接触自然和人群，观察和认识自然现象，了解一些初级科学知识

④ 再次，鼓励学前儿童参加户外活动，有意识地培养孩子勇敢、乐观、大胆等品质

⑤同时，成人要为孩子做出勇敢的榜样

押题 3 参考答案：

（1）

1. 缺乏安全感，心理紧张是主要原因。材料中，菡菡长期在姥姥家，与父母分离。回到陌生的家庭，内心紧张、胆小，通过咬指甲进行自我安慰，缓解情绪。

2. 家长管束太严，加重不良习惯的形成。材料中，妈妈每次看到她咬手指甲，就会打她、批评斥责她。这些情况会导致菡菡在家庭、幼儿园的环境中情绪不安、高度焦虑，则会产生并加重咬手指甲的这种现象。

（2）

1. 矫正咬指甲癖的关键在于消除儿童的紧张心理，而劝诫、惩罚、涂苦药或辣物等均不能取得良好效果。

2. 成人应为儿童创设良好的生活环境，适当安排儿童进行体育活动，使患儿心情愉快，注意力得到转移。

3. 养成按时修指甲的习惯，禁用苦药涂指甲

4. 同时应调动患儿的积极性进行自我矫正

微光也是光

押题 4 参考答案：

（1）材料中明明可能是细菌性痢疾，主要通过以下途径传播感染：

1. 粪-口传播：痢疾杆菌随患者或带菌者的粪便排出，污染手、食物、水源或生活用品，经口进入消化道，引发感染。

2. 饮食污染：食用被痢疾杆菌污染的食物（如不洁的生冷食物、变质食物）或饮用被污染的水，是常见的感染原因。

3. 接触传播：接触被污染的物品（如餐具、玩具、衣物）后，未注意洗手就进食，也可能导致病菌入口。

（2）细菌性痢疾的主要护理措施为：

①要坚持治疗，按医嘱给病儿按时服药，不要刚好一点就把药停了。急性痢疾治疗不彻底，转成慢性痢疾，再治疗就困难了。久病久泻还容易形成小儿脱肛和营养不良。

②病初以流质、半流质为主，忌食多渣、油腻或有刺激性的食物，病情好转后逐步改为软饭，并加强营养。

③每次排便后，用温水洗屁股。

④注意消毒隔离。

微光也是光

押题 5 参考答案：

（1）该幼儿园此次食物中毒属于有毒动、植物性食物中毒中的发芽马铃薯中毒。马铃薯发芽或部分变绿时，其中的龙葵碱大量增加，烹调时又未能去除或破坏掉龙葵碱，食后发生中毒。尤其是春末夏初季节多发。一般在进食后 10 分钟至数小时出现症状。先有咽喉抓痒感及灼烧感，上腹部灼烧感或疼痛，其后出现胃肠炎症状，剧烈呕吐、腹泻。此外，还可出现头晕、头痛、轻度意识障碍、呼吸困难。其症状与材料中幼儿的症状与之相符。

（2）该幼儿园的做法不完全合理。

合理之处在于：教师发现幼儿有中毒现象后当即被送到医院急诊进行治疗，做好善后工作，使食物中毒人员尽快恢复健康。

不合理之处在于：

发生食物中毒事故应立即报告主管校领导，同时报教育行政部门及卫生行政部门，不得拖延时间，不得瞒报、迟报。该幼儿园瞒报了此次中毒事件。

发现食物中毒后应切断污染源，对所食用的有关食物全部封存，供化验和查明原因之用。该幼儿园也并未及时封存食物。

预防食物中毒的措施主要有：

1. 规范采购进货渠道，不购买不新鲜的食物

2. 避免污染，避免生熟食品接触；经常性选手；保持食品操作加工场所清洁；避免昆虫、鼠类等动物接触食品。

3. 食品原材料要清洗干净后再加工，尽量缩短食品存放时间；控制食品的加工量。

4. 对接触食品的所有物品应清洗干净并消毒。

5. 再加热的食品，中心温度必须达到 70° C 以上。

6. 坚持 48h 留样制度，并放带有标识的专柜保存。

材料 6 参考答案：

（1）材料中教师的做法不恰当

1. 让幼儿抬头，会使血液流到咽部，当血量过多。过急时容易呛入气管及肺部。造成呼吸道咽哽

2. 用纸巾堵住，太硬的纸巾容易损伤鼻粘膜

（2）

1. 安慰幼儿，不要紧张，冷静坐下来，头稍微向前倾

2. 压迫止血，捏住鼻翼，压迫 5-10 分钟

3. 若仍在出血，可以用 0.5%的麻黄碱和千分之一的肾上腺素湿棉球填塞出血侧鼻孔，要深达出血处，前额和鼻部用湿毛巾冷敷

4. 若幼儿有频繁吞咽口水的动作，让他把“口水吐出”，如果吐出鲜血，说明出血仍在继续，需送往医院处理

5. 止血后 2-3 小时，不做剧烈运动，避免再次出血

6. 若儿童经常流鼻血，应去医院做全面检查

押题 7 参考答案

（1）原因：

1. 生理特点：幼儿咽鼓管短、宽、直，呈水平位，鼻腔、咽喉与中耳相通，病菌容易进入中耳。

2. 感冒影响：感冒时鼻腔分泌物多，细菌、病毒易通过咽鼓管侵入中耳引发炎症。

3. 擤鼻涕方式错误：捏住双侧鼻孔用力擤鼻涕，会使鼻腔压力过大，带菌分泌物被挤压进入中耳，导致感染。

（2）措施

1. 一般不主张给学前儿童挖耳屎，同时，洗头、洗澡、游戏时注意不让水进入外耳道。

2. 教给幼儿正确的擤鼻涕和打喷涕的方法。先应住一侧的鼻孔挤鼻涕，再压住另一侧擤鼻涕。不要同时接住两侧鼻孔，以防鼻腔压力过大，使病菌进入中耳。

3. 注意卫生，保持空气的流通。在幼儿感冒时要保证身体、面部、环境的卫生，保持室内空气流通，减少感染的机会。

4. 幼儿感冒时应及时就医，根据医生要求按时吃药，注意保暖

押题 8 答案：

（1）该名患儿患的可能是水痘，具体分析如下：

1. 皮疹的发展症状与水痘皮疹发展症状相吻合。材料中，幼儿先由面部出现红色小皮疹，而后迅速蔓延到头皮身上和四肢，且同时拥有红色皮疹和水疱，符合水痘“数代同堂”的皮疹特征。

2. 出现的症状与水痘的发病症状相似。材料中，幼儿出现反复抓挠，焦躁不安等现象，符合水痘的发病症状。

3. 具有传染性强的特征。材料中，保健医生说孩子得了传染性很强的传染病，要立即隔离治疗，水痘是传染性极强的传染病，与之相符。

（2） 护理：水痘主要对症治疗，涂止痒药物，如炉甘石剂、碳酸氢钠溶液等。照料时，重点是防止患儿瘙痒抓伤，造成皮肤感染留下疤痕。给患儿剪短指甲，保持手的清洁卫生。小年龄幼儿可给其戴手套以免抓伤患处。

预防：幼儿园应加强对水痘传染和流行的防范。一旦发现病儿，要及时隔离，隔离时间为皮疹全部结痂脱落（2 周左右）。同时，对病儿用过的物品和房间进行彻底消毒，对接触者进行检疫（检疫期 21 天），阻止水痘流行。目前已有水痘疫苗，家长可视自己孩子的情况决定是否接种。

微光也是光

押题 9 参考答案：

（1）该幼儿患了流行性腮腺炎。

处理与管理措施：

① 立即隔离患儿，暂停入园，及时通知家长接回就医。

② 患儿需居家隔离至腮腺肿胀完全消退，方可返园。

③ 对班级环境、玩具、餐具、毛巾等进行彻底消毒。

④ 加强班级开窗通风，保持空气流通。

⑤ 对密切接触的幼儿进行医学观察 21 天，严格做好晨检、午检。

应进行以下护理：

①注意口腔清洁，常用淡盐水漱口。

②腮腺肿痛可用湿毛巾做冷敷，也可以外敷清热解毒的中药。

③在腮肿期间饮食以流质、软食为宜，避免吃酸、辣的食物。

④可采用中草药治疗，如板蓝根冲剂等。

微光也是光

押题 10 参考答案：

(1)莉莉出现了头外伤中的额头擦伤并出血的意外事故，材料中，表明莉莉撞到长椅上，额头磕破且鲜血直流，符合头外伤中擦伤出血的特征。

(2)

现场急救措施：

①立即让莉莉坐下或躺下，保持安静，避免因哭闹加重出血。

②用干净的纱布或毛巾按压伤口止血，按压时要持续、适度用力，按压时间约 5-10 分钟。

③观察莉莉有无头晕、呕吐、意识不清等症状，初步判断是否有颅脑损伤的可能。

后续护理要点：

①在园护理：止血后，用碘伏轻轻消毒伤口周围皮肤，避免感染，观察莉莉的精神状态、伤口情况，若出现异常及时联系家长并送医。

②回家护理：告知家长保持伤口清洁干燥，避免沾水。若伤口较小，可待其自然结痂愈合；若伤口较大，需遵医嘱定期换药。同时注意观察莉莉是否有头痛、嗜睡等异常表现，如有及时就医。

微光也是光